

【제 목】 상대가치점수의 직접비용 근거자료 구축 효율화 방안 필요(권고)

【내 용】

- 우리 원에서는 지난 2001년부터 「국민건강보험법 시행령」 제21조 제2항에 따라 의료행위의 가치를 각 행위간의 상대적인 점수로 나타낸 상대가치점수를 도입하여 변화하는 보건의료 환경에 맞게 개선·보완하여 사용하고 있다.
- 이에 위원회운영실에서는 5천여 개 의료행위를 대상으로 상대가치 근거자료를 재구축하고 상대가치점수의 불균형 개선 등 새로운 상대가치로 2차 전면 개편하여(「건강보험 행위 급여·비급여 목록표 및 급여 상대가치점수」, 보건복지부 고시 제2017-92호, 2017.7.1.) 2017년 1단계 도입 및 2018년 2단계까지 적용 중에 있다.

☞ 참고자료: 【국민건강보험법 시행령】

제21조(계약의 내용 등) ① (생략)

② 제1항에 따른 요양급여 각 항목에 대한 상대가치점수는 요양급여에 드는 시간·노력 등 업무량, 인력·시설·장비 등 자원의 양, 요양급여의 위험도 및 요양급여에 따른 사회적 편익 등을 고려하여 산정한 요양급여의 가치를 각 항목 사이에 상대적인 점수로 나타낸 것으로 하며, 보건복지부장관이 심의위원회의 심의·의결을 거쳐 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 고시한다.

③~④ (생략)

☞ 참고자료: 【보건복지부 고시 제2017-92호】

「국민건강보험법 시행령」 제21조제2항·제3항 및 「국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙」 제8조제2항부터 제5항까지, 제9조제1항, 제11조제1항, 제12조제2항 및 제13조제1항·제3항에 의한 「건강보험 행위 급여·비급여목록표 및 급여 상대가치점수」(보건복지부 고시 제2017-90호, 2017. 5. 30.)를 다음과 같이 개정·발령 합니다

- 상대가치점수는 업무량, 진료비용, 위험도로 구성되어 있으며, 업무량은 의협, 한의협, 치의협, 약사회 등 관련 단체가, 진료비용은 임상전문가패널(CPEP)과 심평원이, 위험도는 전문연구기관에서 산출하고 있다.
- 이 중 진료비용은 수가 산정의 근거를 명확히 하여 상대가치를 합리적으로 산정하기 위하여 의사, 치과의사, 한의사, 간호사, 의료기사 등이 참여하는 약 220여명의 임상전문가패널(CPEPs: Clinical Practice Expert Panels)이 의료행위별로 인건비, 장비비, 재료비에 대한 직접비용을 구축하고 있다.
- 그런데 임상전문가패널이 구축한 직접비용 자료를 메일이나 커뮤니티를 통해 받고 있고 자료의 양이 방대하여(Excel 파일 약 43만줄) 상대가치개발부에서 입력 과정의 오류 및 자료를 검증하는데 여러 단계의 수작업으로 장시간이 소요되는 등 어려움이 있는 것으로 확인되었다.

【조치할 사항】

○ 진료심사평가위원장은

상대가치점수의 직접비용 근거자료 구축 시 실시간 입력 및 검증을 위한 시스템을 개발하여 임상전문가패널과 심평원의 업무를 효율화 방안을 마련하시기 바랍니다.